

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий
Министерства здравоохранения
и социального развития
Кыргызской Республики
Кагаздиев Н.М. 
«09» _____ 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ТВАРДОКС Н

Торговое название:

Твардокс Н

Международное непатентованное название:

Телмисартан + Гидрохлоротиазид

Лекарственная форма:

Таблетки для приёма внутрь.

Состав:

Твардокс Н40: каждая таблетка содержит:

Активные вещества:

Телмисартан 40 мг

Гидрохлоротиазид 12,5 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, гидроксид натрия, полисорбат 80, триэтаноламин, повидон, гипромеллоза, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль), магния стеарат, натрия крахмалгликолят, оксид железа красный.

Твардокс Н80: каждая таблетка содержит:

Активные вещества:

Телмисартан 80 мг

Гидрохлоротиазид 12,5 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, гидроксид натрия, полисорбат 80, триэтаноламин, повидон, гипромеллоза, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль), магния стеарат, натрия крахмалгликолят, оксид железа красный.

Описание:

Непокрытые таблетки, двухслойные (один слой почти белого цвета, а другой слой розового цвета), двояковыпуклые, капсуловидные, плоские с обеих сторон.

Фармакотерапевтическая группа:

Ангиотензина II антагонисты в комбинации с другими препаратами. Ангиотензина II антагонисты в комбинации с диуретиками. Телмисартан и диуретики.

Код АТХ: C09DA07.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Твардокс Н представляет собой комбинацию антагониста рецепторов ангиотензина II - телмисартана и тиазидного диуретика - гидрохлоротиазида. Комбинация этих составляющих обеспечивает более высокий уровень антигипертензивного эффекта, чем прием каждого из компонентов в отдельности.

Прием препарата Твардокс Н один раз в день в терапевтических дозах обеспечивает эффективное и плавное снижение артериального давления.

Телмисартан: является эффективным и специфическим (селективным) антагонистом рецепторов ангиотензина II (типа AT1). Телмисартан с очень высокой степенью сродства образует связь только с подтипом AT1 – рецепторов ангиотензина II. Телмисартан не обладает сродством к другим рецепторам, в том числе к AT2 – рецепторам ангиотензина, и к другим, менее изученным, AT рецепторам. Функциональное значение этих рецепторов, а также эффект их возможной избыточной стимуляции ангиотензином II, концентрация которого увеличивается при назначении телмисартана, не изучены.

Телмисартан приводит к снижению уровня альдостерона в крови. Телмисартан не ингибирует ренин в плазме человека и не блокирует ионные каналы. Телмисартан не подавляет активность ангиотензин превращающего фермента (киназа II), с участием которого происходит снижение синтеза брадикинина. Поэтому нет усиления побочных эффектов, вызываемых брадикинином.

У пациентов телмисартан в дозе 80 мг практически полностью блокирует гипертензивное действие ангиотензина II. Ингибирующее действие сохраняется в течение 24 часов и остается значимым до 48 часов.

После приема первой дозы телмисартана антигипертензивная активность постепенно становится заметной в течение 3 часов. Максимальное снижение артериального давления постепенно достигается через 4 недели после начала лечения и поддерживается в течение длительного лечения.

У пациентов с гипертензией телмисартан снижает систолическое и диастолическое артериальное давление без изменения частоты сердечных сокращений.

Антигипертензивная эффективность телмисартана сопоставима с антигипертензивными препаратами других классов (что продемонстрировано в клинических исследованиях сравнения телмисартана с амлодипином, атенололом, эналаприлом, гидрохлоротиазидом, лозартаном, лизиноприлом, рамиприлом и валсартаном).

В случае резкой отмены телмисартана артериальное давление постепенно возвращается к значениям до лечения в течение нескольких дней без признаков быстрого возобновления гипертензии (нет синдрома «отмены»).

В клинических исследованиях при прямом сравнении двух видов антигипертензивного лечения частота случаев сухого кашля у пациентов, принимавших телмисартан, была значительно ниже, чем у получавших ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента.

Гидрохлоротиазид: является тиазидным диуретиком. Механизм антигипертензивного эффекта тиазидных диуретиков полностью не известен. Тиазиды действуют на почечные тубулярные механизмы реабсорбции электролитов, прямо повышая выделение натрия и хлорида в приблизительно эквивалентных количествах. Диуретическое действие гидрохлоротиазида уменьшает объем плазмы, повышает активность ренина плазмы, повышает секрецию альдостерона с последующим увеличением потери калия и бикарбоната с мочой и снижением калия в сыворотке. Предположительно сквозная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при сочетанном приеме телмисартана имеет тенденцию к обратимости потери калия, связанной с этими диуретиками.

При приеме гидрохлоротиазида повышение диуреза наблюдается через 2 часа, максимальный эффект наступает приблизительно через 4 часа, в то время как продолжительность действия составляет около 6-12 часов.

Эпидемиологические исследования показали, что длительное лечение гидрохлоротиазидом уменьшает риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности от них.

Фармакокинетика:

Одновременное применение гидрохлоротиазида и телмисартана не оказывает влияния на фармакокинетику этих препаратов.

Всасывание

Телмисартан: после приема внутрь телмисартан абсорбируется быстро, максимальная концентрация телмисартана достигается через 0,5–1,5 ч. Средняя абсолютная биодоступность телмисартана – около 50%. Прием пищи незначительно снижает биодоступность телмисартана с уменьшением значения площади под кривой «концентрация в плазме - время» (AUC) от 6% при приеме в дозе 40 мг до 19% при приеме в дозе 160 мг. Через 3 ч после приема телмисартана концентрация в плазме крови стабилизируется и не зависит от приема пищи. Незначительное уменьшение AUC не вызывает снижения терапевтической эффективности.

Фармакокинетика телмисартана при пероральном приеме имеет нелинейный характер при приеме доз в диапазоне 20 мг - 160 мг с более чем пропорциональным увеличением концентраций в плазме (C_{max} и AUC) при увеличении дозы. Телмисартан не накапливается в плазме крови в значительной мере при повторном применении.

Гидрохлоротиазид: после приема внутрь максимальная концентрация гидрохлоротиазида достигается приблизительно через 1,0-3,0 часа после приема. Абсолютная биодоступность гидрохлоротиазида составляет приблизительно 60%.

Распределение

Телмисартан: обладает высокой степенью связывания с белками плазмы (>99,5%), в основном с альбумином и альфа-1 кислотным гликопротеином. Объем распределения составляет приблизительно 500 л.

Гидрохлоротиазид: на 6% связывается с белками плазмы и его видимый объем распределения составляет 0,8 - 0,3 л/кг.

Метаболизм и выведение

Телмисартан: после перорального применения, ¹⁴C-меченного телмисартана большая часть дозы (> 97%) выводилась с калом путем билиарной экскреции; очень незначительные количества были обнаружены в моче. Метаболизируется путем конъюгирования исходного вещества с фармакологически неактивным ацилглюкуронидом, единственным глюкуронидом, идентифицированным у человека.

После применения одной дозы ¹⁴C-меченного телмисартана глюкуронид обнаруживается приблизительно 11% измеренной радиоактивности в плазме крови. Изоферменты цитохрома P450 не участвуют в метаболизме телмисартана. Общий плазменный клиренс телмисартана составляет приблизительно 1500 мл/мин, терминальный период полувыведения более 20 часов.

Гидрохлоротиазид: у человека не метаболизируется и выделяется почти полностью в неизменном виде с мочой. Около 60% принятой внутрь дозы выводится в виде неизменного вещества в течение 48 часов. Почечный клиренс составляет приблизительно 250-300 мл/мин. Конечный период полувыведения гидрохлоротиазида составляет 10-15 часов.

Пациенты пожилого возраста: фармакокинетика телмисартана у пациентов пожилого возраста и моложе 65 лет не отличается.

Пол: концентрация телмисартана в плазме крови у женщин в 2–3 раза выше, чем у мужчин. Однако в клинических исследованиях не было выявлено значительного повышения артериального давления или частоты случаев ортостатической гипотензии у женщин. Нет необходимости в коррекции дозы. Отмечалась тенденция к более высокой концентрации гидрохлоротиазида в плазме крови у женщин, по сравнению с мужчинами.

Клинически значимая кумуляция телмисартана не обнаружена.

Пациенты с почечной недостаточностью

Почечная экскреция не влияет на клиренс телмисартана. На основании опыта применения препарата у пациентов со слабой и умеренно выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–60 мл/мин, в среднем около 50 мл/мин) показано, что коррекция дозы не является необходимой у пациентов со сниженной функцией почек. Телмисартан не выводится из крови во время гемодиализа. У пациентов с нарушениями функции почек скорость выведения гидрохлоротиазида понижена.

В исследовании у пациентов со средним клиренсом креатинина 90 мл/мин период полувыведения гидрохлоротиазида был увеличен. У пациентов с нефункционирующей почкой период полувыведения составляет около 34 часов.

Пациенты с печеночной недостаточностью

У пациентов с печеночной недостаточностью наблюдается увеличение абсолютной биодоступности до 100%. Период полувыведения не изменяется при печеночной недостаточности.

Показания к применению:

- артериальная гипертензия (в случае неэффективности телмисартана или гидрохлоротиазида в монотерапии).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- беременность и период лактации;
- холестаз и обструктивные заболевания желчевыводящих путей;
- тяжелые нарушения функции печени (класс С по шкале Чайлд-Пью);
- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
- стойкая гипокалиемия и гиперкальциемия;
- совместный прием препарата Твардокс Н с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или почечной недостаточностью (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м²);
- возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не установлены);
- наследственная форма непереносимости фруктозы.

С осторожностью:

- двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки;
- тяжелые нарушения функции почек;
- нарушения функции печени или прогрессирующие заболевания печени (класс А и В по шкале Чайлд-Пью);
- снижение ОЦК вследствие предшествующей терапии диуретиками, ограничения приема поваренной соли, диареи или рвоты;
- гиперкалиемия;
- состояние после трансплантации почки (опыт применения отсутствует);
- хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК (функциональный класс) по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации;
- стеноз аортального и митрального клапана;
- идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз;
- гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;
- сахарный диабет;
- первичный альдостеронизм;
- подагра;
- опыт применения у пациентов с почечной недостаточностью (КК более 30 мл/мин) ограничен, но не подтверждает развитие побочных эффектов со стороны почек и коррекции дозы не требуется.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Твардокс Н противопоказано во время беременности.

Телмисартан

Использование антагонистов рецепторов ангиотензина II во время первого триместра беременности не рекомендуется, эти препараты не следует назначать во время беременности. При диагностировании беременности прием препарата следует немедленно прекратить. При необходимости должна назначаться альтернативная терапия (другие классы гипотензивных препаратов, разрешенных к применению во время беременности). Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II во время второго и третьего триместров беременности противопоказано.

В доклинических исследованиях телмисартана тератогенных влияний выявлено не было, но установлена фетотоксичность. Известно, что воздействие антагонистов рецепторов ангиотензина II во время второго и третьего триместров беременности вызывает у человека фетотоксичность (снижение функции почек, олигогидроамнион, замедление оссификации черепа), а также неонатальную токсичность (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). Пациенткам, планирующим беременность следует назначать альтернативную терапию. Если лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II происходило во время второго триместра беременности, рекомендуется проверка ультразвуковым методом функции почек и состояния черепа у плода. Новорожденные, матери которых получали антагонисты рецепторов ангиотензина II, должны тщательно наблюдаться в отношении гипотензии.

Гидрохлоротиазид

Опыт применения гидрохлоротиазида во время беременности, особенно во время первого триместра, ограничен.

Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. Учитывая фармакологический механизм действия гидрохлоротиазида, предполагается, что его использование во время второго и третьего триместров беременности может нарушать фетоплацентарную перфузию и вызывать такие изменения у эмбриона и плода, как желтуха, нарушения электролитного баланса и тромбоцитопения.

Гидрохлоротиазид не должен применяться при отеках беременных, при гипертензии беременных или вовремя преэклампсии, так как существует риск снижения объема плазмы и снижения плацентарной перфузии, а благоприятный эффект при указанных клинических ситуациях отсутствует.

Гидрохлоротиазид не должен применяться для лечения эссенциальной гипертензии у беременных, за исключением тех редких ситуаций, когда не могут использоваться другие виды лечения.

Терапия препаратом Твардокс Н противопоказана в период грудного вскармливания.

Исследования влияния на фертильность человека не проводились.

Способ применения и дозы:

Твардокс Н принимают 1 раз в день, запивая небольшим количеством воды.

Твардокс Н 40 мг может назначаться пациентам, у которых применение препарата Твардокс в дозе 40 мг или гидрохлоротиазида не приводит к адекватному контролю АД.

Твардокс Н 80 мг может назначаться пациентам, у которых применение препарата Твардокс в дозе 80 мг или Твардокс Н 40 мг не приводит к адекватному контролю АД.

У пациентов с артериальной гипертензией тяжелой степени максимальная суточная доза телмисартана 160 мг в сутки. Данная доза хорошо переносима и эффективна.

Нарушения функции почек:

При небольших или умеренных нарушениях функции почек не требуется изменений дозы препарата. У таких пациентов следует контролировать функцию почек (при КК более 30 мл/мин).

Нарушения функции печени:

У пациентов со средней и умеренной степенью нарушения печеночной функции доза препарата не должна превышать 40/12,5 мг один раз в сутки.

Пожилые пациенты:

Не требуется коррекции дозы у пожилых пациентов.

Побочные действия:

- ¹⁾ ожидающиеся на основании опыта применения телмисартана
- ²⁾ ожидающиеся на основании опыта применения гидрохлоротиазида
- ³⁾ побочные эффекты, которые не наблюдались в клинических исследованиях при одновременном применении телмисартана и гидрохлоротиазида, но ожидаются во время применения препарата Твардокс Н.

Со стороны дыхательной системы: респираторный дистресс синдром (включая пневмонию и отек легких)³⁾, одышка³⁾

Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии³⁾, тахикардия³⁾, брадикардия¹⁾, выраженное снижение АД (включая ортостатическую гипотензию)³⁾

Со стороны центральной нервной системы: обморок/предобморочное состояние³⁾, парестезии³⁾, нарушения сна³⁾, бессонница³⁾, головокружение^{2) 3)}, тревога³⁾, депрессия³⁾, повышенная возбудимость²⁾.

Со стороны пищеварительной системы: диарея³⁾, сухость слизистой оболочки полости рта³⁾, метеоризм³⁾, боль в животе³⁾, запор³⁾, рвота³⁾, гастрит³⁾, снижение аппетита²⁾, анорексия²⁾, гипергликемия²⁾, гиперхолестеринемия²⁾, панкреатит²⁾, нарушение функции печени³⁾, заболевания печени³⁾, желтуха (гепатоцеллюлярная или холестатическая)²⁾, диспепсия^{1) 2) 3)}.

Со стороны кожных покровов: повышенное потоотделение³⁾

Со стороны костно-мышечной системы: боль в спине³⁾, спазмы мышц³⁾, миалгия³⁾, артралгия³⁾, судороги икроножных мышц³⁾, боль в нижних конечностях³⁾, артроз¹⁾, боль в сухожилиях (тендинитоподобные симптомы)¹⁾, боль в грудной клетке³⁾.

Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы: анемия¹⁾, апластическая анемия²⁾, гемолитическая анемия²⁾, тромбоцитопения^{1) 2)}, эозинофилия¹⁾, лейкопения²⁾, нейтропения/агранулоцитоз²⁾, угнетение функции костного мозга²⁾.

Со стороны мочевыделительной системы: почечная недостаточность, включая острую почечную недостаточность¹⁾, интерстициальный нефрит²⁾, глюкозурия²⁾.

Со стороны органов чувств: нарушение зрения³⁾, преходящая нечеткость зрения³⁾, ксантопсия²⁾.

Со стороны репродуктивной системы: импотенция³⁾.

Инфекции: сепсис, включая случаи с летальным исходом¹⁾, инфекции верхних дыхательных путей (бронхит, фарингит, синусит)^{1) 3)}, инфекции мочевыводящих путей (включая цистит)¹⁾, воспаление слюнных желез²⁾.

Метаболические нарушения: повышение концентрации креатинина в плазме крови³⁾, повышение активности печеночных ферментов³⁾, повышение активности креатинфосфокиназы³⁾, повышение концентрации мочевой кислоты крови³⁾, гипертриглицеридемия²⁾, гипокалиемия³⁾, гиперкалиемия¹⁾, гипонатриемия³⁾, нарушение водно-электролитного баланса²⁾, гиперурикемия³⁾, снижение ОЦК²⁾, гипогликемия (у пациентов с сахарным диабетом)¹⁾, ухудшение гликемического контроля²⁾, снижение уровня гемоглобина в крови¹⁾.

Аллергические реакции: ангионевротический отек (включая случаи с летальным исходом)³⁾, эритема³⁾, кожный зуд³⁾, сыпь³⁾, крапивница³⁾, анафилактические реакции^{1) 2)}, аллергические реакции¹⁾, экзема¹⁾, лекарственная сыпь^{1) 2)}, токсический эпидермальный некроз^{1) 2)}, токсическая кожная сыпь¹⁾, волчаночноподобные кожные проявления²⁾, обострение или усиление кожных симптомов системной красной волчанки³⁾, некротический васкулит²⁾, кожный васкулит²⁾, реакция фотосенсибилизации²⁾, ухудшение течения или обострение системной красной волчанки²⁾, некротический ангиит (васкулит)²⁾.

Прочие: гриппоподобный синдром³⁾, лихорадка²⁾, болевой синдром различной локализации³⁾, слабость^{1) 2)}.

Передозировка:

Случаи передозировки не выявлены. Возможные симптомы передозировки складываются из симптомов со стороны отдельных компонентов препарата.

Телмисартан - выраженное снижение АД, тахикардия, брадикардия.

Гидрохлоротиазид - нарушения водно-электролитного баланса крови (гипокалиемия, гипохлоремия), снижение ОЦК, что может приводить к спазмам мышц и/или усиливать нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии, вызываемые одновременным применением сердечных гликозидов или некоторых антиаритмических средств.

Лечение: симптоматическая терапия, гемодиализ не эффективен. Степень удаления гидрохлоротиазида при проведении гемодиализа не установлена. Необходим регулярный контроль содержания электролитов и креатинина в сыворотке крови.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении Твардокс Н с:

- литием наблюдаются редкие случаи обратимого увеличения концентрации лития в сыворотке крови и развития интоксикации литием, вследствие снижения почечного клиренса лития. В этой связи совместное применение лития и Твардокс Н не рекомендуется. При необходимости совместного назначения этих препаратов следует проводить мониторинг уровня лития в плазме крови, а пациенты должны находиться под строгим наблюдением врача;
- препаратами, приводящими к потере калия и гипокалиемии (калиевые диуретики, слабительные, кортикостероиды, гормоны коры надпочечников, амфотерицин, карбеноксолон, натриевая соль пенициллина G, салициловая кислота и ее производные) следует проводить строгий контроль уровня калия в плазме крови. Эти препараты могут потенцировать гипокалиемический эффект гидрохлоротиазида. При назначении этих лекарственных средств одновременно с Твардокс Н рекомендуется проводить мониторинг уровня калия в плазме крови;
- препаратами, угнетающими ренин-ангиотензиновую систему, одновременно с калийсберегающими диуретиками, калиевыми добавками, калийсодержащими заменителями соли и другими препаратами, которые могут способствовать повышению уровня калия (например, натриевая соль гепарина), возможно повышение уровня калия в сыворотке крови. Если необходимо назначение этих лекарственных средств с Твардокс Н, рекомендуется контролировать уровень калия в плазме крови;
- лекарственными средствами, зависящими от колебания уровня калия в крови (гликозиды наперстянки), антиаритмическими средствами, следует проводить периодический мониторинг уровня калия в сыворотке крови и проведение электрокардиографии, поскольку гипокалиемия является предрасполагающим фактором для возникновения пароксизмальной желудочковой тахикардии типа «пируэт»;
- нестероидными противовоспалительными средствами возможно снижение диуретических, натрийуретических и антигипертензивных эффектов тиазидных диуретиков у некоторых пациентов. У пожилых пациентов и обезвоженных больных может повыситься риск развития острой почечной недостаточности, поэтому следует проводить достаточную гидратацию и мониторинг функции почек;
- другими антигипертензивными препаратами возможно потенцирование их гипотензивного эффекта;
- телмисартаном и рамиприлом приводит к повышению AUC₀₋₂₄ и C_{max} рамиприла и рамиприлата до 2,5 раз. Клиническая значимость этого наблюдения не известна;
- алкоголем, барбитуратами, наркотическими средствами возможно потенцирование ортостатической гипотензии;
- противодиабетическими средствами (пероральные и инсулин) может потребоваться коррекция дозы противодиабетических средств;
- метформином возникает риск развития лактацидоза, обусловленного совместным назначением гидрохлоротиазида;
- холестирамином и холестериновыми смолами нарушается всасывание гидрохлоротиазида;
- гликозидами наперстянки возможна гипокалиемия или гипомagneмия, вызванные тиазидами, что может способствовать началу сердечной аритмии, индуцированной гликозидами наперстянки;
- прессорными аминами (норадреналин) уменьшается влияние прессорных аминов;
- недеполяризующими релаксантами скелетной мускулатуры (тубокурарин) наблюдается потенцирование эффекта недеполяризующих релаксантов;

- препаратами для лечения подагры может потребоваться коррекция дозы урикозурических средств, так как гидрохлоротиазид способен повышать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Совместный прием с аллопуринолом может привести к реакции гиперчувствительности на аллопуринол;
- солями кальция возможно увеличение уровня кальция в крови из-за уменьшения его элиминации. Если назначаются витамины, содержащие кальций, следует проводить контроль его уровня в крови и, соответственно, скорректировать дозу;
- бета-блокаторами и диазоксидом возможно потенцирование гипергликемического эффекта бета-блокаторов и диазоксида;
- антихолинергическими средствами (атропин, биперидин) возможно увеличение биодоступности тиазидных диуретиков путем уменьшения моторики желудочно-кишечного тракта и скорости опорожнения желудка;
- амантадином возможно увеличение риска развития побочных эффектов, вызванных приемом амантадина;
- цитотоксичными препаратами (циклофосфамид, метотрексат) возможно снижение почечной экскреции цитотоксичных препаратов и потенцирование их миелосупрессивных эффектов.

Совместное использование Твардокс Н с дигоксином, варфарином, гидрохлоротиазидом, глибенкламидом, ибупрофеном, парацетамолом, симвастатином и амлодипином не приводит к клинически значимому взаимодействию. При одновременном применении с дигоксином наблюдалось повышение средней минимальной концентрации дигоксина в плазме крови на 20 % (в единичном случае на 39%), поэтому необходимо проводить мониторинг уровня дигоксина в плазме крови.

Особые указания:

Печеночная недостаточность

Твардокс Н противопоказан пациентам с холестазом, обструктивными заболеваниями желчевыводящих путей или выраженными нарушениями функции печени, поскольку телмисартан выводится преимущественно с желчью. У таких больных можно ожидать понижения печеночного клиренса, обусловленного телмисартаном.

Реноваскулярная гипертензия

У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной функционирующей почки, принимающих лекарственные препараты, которые влияют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, существует повышенный риск развития тяжелой гипотензии и почечной недостаточности.

Почечная недостаточность и трансплантация почки

Твардокс Н противопоказан больным с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин).

Опыт использования Твардокс Н у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или недавней трансплантацией почки отсутствует. Опыт применения Твардокс Н у пациентов с небольшими или умеренными нарушениями функции почек ограниченный, поэтому рекомендуется периодический контроль уровня калия, креатинина и мочевой кислоты в сыворотке. У пациентов с почечной недостаточностью может развиваться азотемия, связанная с использованием тиазидных диуретиков.

Снижение объема циркулирующей крови (ОЦК)

У пациентов со сниженным ОЦК и/или сниженным содержанием натрия вследствие интенсивной терапии диуретиками, снижением потребления соли с пищей, диареей или рвотой, может наблюдаться симптоматическая гипотензия, особенно после приема первой дозы. Такие состояния следует корректировать до назначения Твардокс Н.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы:

При совместном применении лекарственных средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, вследствие блокирования этой системы были выявлены изменения функции почек (в т.ч. острая почечная недостаточность) у пациентов с патологией почек. Поэтому применение двойной блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например, при добавлении ингибитора АПФ к антагонисту рецепторов ангиотензина II) должны быть частными случаями при условии тщательного мониторинга функции почек.

Другие состояния, связанные со стимуляцией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

У пациентов со сниженным сосудистым тонусом и функцией почек, в значительной степени, зависящей от активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например, пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или тяжелыми заболеваниями почек, включая стеноз почечной артерии), лечение Твардокс Н с другими препаратами, влияющими на эту систему, может привести к риску развития острой гипотензии, гиперазотемии, олигурии или, в редких случаях, острой почечной недостаточности

Первичный альдостеронизм

Пациенты с первичным альдостеронизмом обычно не реагируют на лечение антигипертензивными средствами, действующими посредством ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому применение Твардокс Н не рекомендуется.

Стеноз аорты и митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

Как и при использовании других сосудорасширяющих лекарств у пациентов, страдающих аортальным или митральным стенозом или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией, применение Твардокс Н требует особой осторожности.

Метаболические и эндокринные эффекты

У пациентов с сахарным диабетом может потребоваться изменение дозы инсулина или гипогликемических средств для приема внутрь. Во время проведения терапии тиазидными диуретиками возможно проявление латентно протекающего сахарного диабета.

Была обнаружена связь между повышением уровня холестерина и триглицеридов и применением тиазидных диуретиков; однако при применении Твардокс Н с содержанием 12,5 мг гидрохлоротиазида отмечался минимальный эффект или его отсутствие. У некоторых пациентов, получающих лечение Твардокс Н, может наблюдаться гиперурикемия и приступы подагры.

Нарушение водно-электролитного баланса

Как при применении препарата Твардокс Н, так и в случае проведения диуретической терапии необходим периодический контроль содержания электролитов в сыворотке крови. Тиазидные диуретики, в т.ч. гидрохлоротиазид, могут вызывать нарушение водно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния (гипокалиемию, гипонатриемию и гипохлоремический алкалоз). Признаками,стораживающими в отношении этих нарушений, являются сухость слизистой оболочки полости рта, чувство жажды, общая слабость, сонливость, чувство беспокойства, миалгия или судорожные подергивания икроножных мышц (судороги), мышечная слабость, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия и такие желудочно-кишечные нарушения, как тошнота или рвота.

При применении тиазидных диуретиков может развиваться гипокалиемия, но одновременно применяющийся телмисартан может повышать содержание калия в крови. Риск гипокалиемии наиболее возрастает у пациентов с циррозом печени, при усиленном диурезе, при соблюдении бессолевой диеты, а также в случае одновременного применения глюко- и минералокортикостероидов или кортикотропина. Телмисартан, входящий в состав препарата Твардокс Н, наоборот, может привести к гиперкалиемии вследствие антагонизма к рецепторам ангиотензина II (подтип AT1). Хотя при применении препарата Твардокс Н клинически значимая гиперкалиемия не была зарегистрирована, следует принимать во внимание, что к факторам риска ее развития относятся почечная и/или сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Данных о том, что препарат Твардокс Н может уменьшать или предотвращать гипонатриемию, вызываемую приемом диуретиков, нет. Гипохлоремия обычно незначительна и лечения не требует.

Тиазидные диуретики могут уменьшать выведение кальция почками и вызывать (при отсутствии явных нарушений метаболизма кальция) преходящее и небольшое повышение содержания кальция в сыворотке крови. Более выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. Перед проведением оценки функции паращитовидных желез тиазидные диуретики должны быть отменены.

Показано, что тиазидные диуретики увеличивают выведение магния почками, что может привести к гипомагниемии.

Сахарный диабет

У больных сахарным диабетом с дополнительным фактором сердечно-сосудистого риска, например, с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС), риск инфаркта миокарда и внезапной смерти по причине сердечно-сосудистой патологии может повышаться при лечении препаратами, понижающими артериальное давление, такими как блокаторы рецепторов ангиотензина II или ингибиторы АПФ. ИБС у пациентов с сахарным диабетом может протекать бессимптомно и, следовательно, не быть диагностированной. Пациенты с сахарным диабетом должны пройти соответствующую диагностику, например, стресс-тестирование, для выявления и соответствующего лечения ИБС до начала приема Твардокс Н.

Дополнительно

При использовании антигипертензивных веществ резкое и чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемической кардиопатией или ишемическим сердечно-сосудистым заболеванием может привести к инфаркту миокарда или развитию инсульта.

Общие

Реакции повышенной чувствительности к гидрохлоротиазиду могут наблюдаться у пациентов даже при отсутствии аллергии или бронхиальной астмы в анамнезе, однако с большей вероятностью отмечаются при наличии этих заболеваний.

Имеются сообщения об обострении или активации системной эритематозной волчанки при использовании тиазидных диуретиков.

Острая миопия и вторичная закрытоугольная глаукома

Гидрохлоротиазид, являющийся производным сульфонамида, может вызвать реакцию идиосинкразии (индивидуальной непереносимости), приводящую к возникновению кратковременной острой миопии и вторичной закрытоугольной глаукомы. Симптомы включают острое начало снижения остроты зрения или боль в глазу, что обычно наблюдается в период от нескольких часов до нескольких недель с момента начала приема препарата.

Отсутствие лечения острой закрытоугольной глаукомы может привести к необратимой потере зрения! Первичное лечение состоит в срочном прекращении приема гидрохлоротиазида! Немедленное медицинское или хирургическое лечение может быть необходимо, если не удастся восстановить внутриглазное давление. Факторы риска развития острой закрытоугольной глаукомы могут включать в себя наличие в анамнезе аллергических реакция на сульфонамид или пенициллин.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Исследования влияний на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не проводились. Управление автотранспортом или приборами следует ограничить в период проведения антигипертензивной терапии из-за возможности развития головокружения или сонливости.

Форма выпуска:

Твардокс Н40 мг или Н80 мг:

7 таблеток для приёма внутрь в каждом блистере.

4 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения:

VEGAPHARM LLP

Astra House, Arklow Road,
London, England SE14 6EB, UK (Великобритания)

Производитель:

IND-SWIFT LIMITED

Off. NH-21, Village Jawaharpur,
Tehsil Derabassi, District SAS Nagar (Mohali),
Punjab-140507, India (Индия)

Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукции (товара):

ОсОО «Аман Фарм» (Аман Фарм), Республика Кыргызстан, город Бишкек,
ул. Шоорукова 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com